飞秒激光辅助白内障手术规范

2018 专家共识 · 正面

患者选择

能配合、角膜透明、睑裂合适。解剖/固视不适、激光阻挡、活动角膜问题、低眼压等禁忌须排查。

2018 刊p328

高风险评估

散大瞳孔<5 mm、未控制青光眼、薄壁滤过泡、明显半脱位等须严密评估。

2018 刊p328–329

切囊参数

通常5.0～5.2 mm；可设4.5～6.0 mm；硬核/可调节IOL 5.5 mm。360°覆盖IOL边缘。

2018 刊p330

预劈核/切口

IV级及以上硬核建议预劈核；后极性暂不建议。角膜切口非必需；松解切口可考虑规则散光1.00～1.50 D。

2018 刊p330

飞秒激光辅助白内障手术规范

2018 专家共识 · 背面

缩瞳预防

术前1 h内散瞳+NSAID；NSAID术前1 d，3或4次、每次1滴。激光后1%复方托吡卡胺1滴；15～20 min内超乳。

2018 刊p330–331

异常处理

脱吸迅速停激光，重放接口；反复失败改超乳。切囊不全手法完成；不确定可染色，不突然快速取囊。

2018 刊p330–331

后囊安全

保守扫描、观察眼位；减气泡、避免过量黏弹剂，水分离前囊袋减压；后极性更谨慎。

2018 刊p331

随访

术后1 d、7 d、1个月：视力/眼压/前房；异常及时就诊。激光统一能量和完整药物禁忌原文未明确。

2018 刊p328–332